

# Crisis convulsiva en la infancia

Bibliográfica 2021 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David  
Pediatría Integral Octubre-Noviembre de 2020  
PRONAP 2018 Módulo 2  
EducaSap 2014

## Definición

Aparición transitoria de signos y/o síntomas provocados por una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro (definición propuesta por la ILAE 2017: International League Against Epilepsy).

## Epidemiología

Aparecen en 10% de los niños

Incidencia de epilepsias: 20-70 casos/1000 habitantes, más frecuentes en varones (en adolescentes más frecuente en mujeres)

## Etiología

### 1. Origen extracerebral (más frecuente)

- Fiebre elevada
- Infección
- Metabólica:
  - Hipoglucemia
  - Hipoxia
  - Hipomagnesemia
  - Hipocalcemia
  - Hipercapnia
  - Déficit de piridoxina
- Arritmias cardíacas
- Toxinas:
  - Alcohol
  - Plomo
  - Codeína
  - Salicilatos
  - Anfetaminas

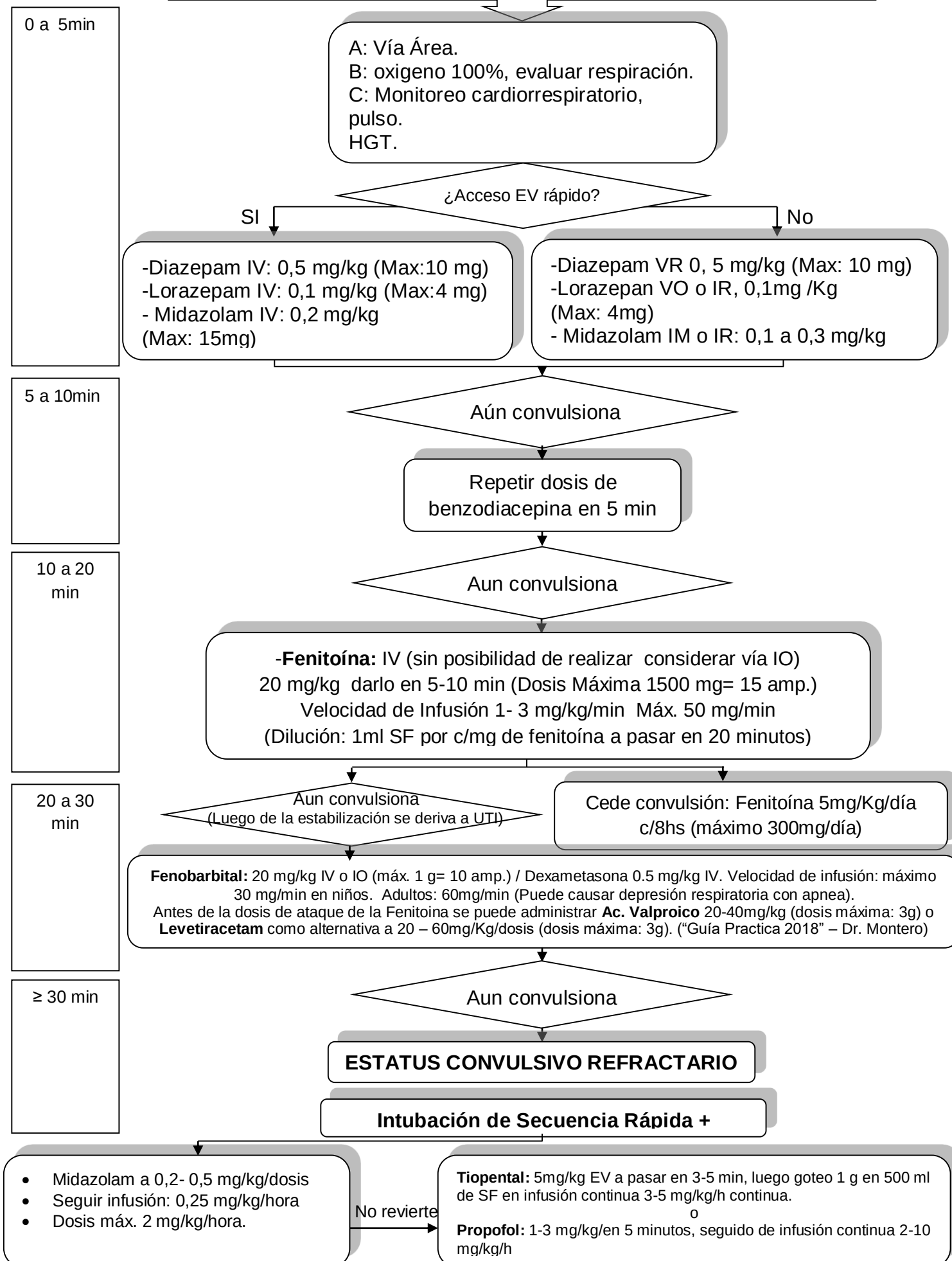
### 2. Intracerebral

- Infección del SNC
  - Meningitis
  - Encefalitis
  - Absceso cerebral
  - Neurocisticercosis
- TEC
- Hemorragia intracerebral
- ACV
- Epilepsias

## Pseudocrisis convulsiva

- Espasmo sollozo
- RGE (S° de Sandifer)
- Origen psiquiátrico
- Mioclonías benignas de la infancia
- Migrañas
- Síncope y distonías neurovegetativas
- Tics
- Mioclonías neonatales benignas del sueño

# 1- Manejo del estatus convulsivo en la Emergencia



## **Convulsiones febriles**

### **Definición**

Crisis que se asocian a fiebre de más de 38°C, en niños de 6 meses a 5 años, excluyendo las causadas por infecciones del sistema nervioso central (SNC) u otra causa definida, y sin antecedentes de crisis afebriles. Aunque algunos autores amplían el rango de edad, incluyendo crisis desde los 3 meses, e incluso según la ILAE (*International League Against Epilepsy*) desde el mes de vida.

Su causa más frecuente son las infecciones virales.

Son el resultado de una sensibilidad a la fiebre en un cerebro en desarrollo con predisposición genética.

### **Clasificación:**

#### **F. Simple (o típica)**

Características (Academia Americana de Pediatría 1996 -1999).

- Son generalizadas
- No recurren dentro de las 24 horas
- Se presentan en niños sin trastornos neurológicos, con desarrollo psicomotor normal y sin crisis afebriles previas
- La fiebre puede no ser detectada antes de la crisis, pero debe estar presente en el momento inmediato a la pos crisis (dentro de las 24hs)
- Ocurren en mayores de 6 meses y menores de 6 años
- Duración menor a 10 minutos (15 en algunas bibliográficas)
- Post-ictal sin signos de déficit motriz ni sensorial
- Sin antecedentes familiares de epilepsia.

#### **C.F. Compleja (o atípica)**

- Focalizadas
- Prolongadas (más de 10 o 15 minutos, según bibliográfica)
- Repetidas durante la misma enfermedad febril
- Su recuperación en general es más lenta, pudiendo tener incluso alguna anomalía post-ictal transitoria (parálisis de Todd por ejemplo)
- Pueden estar asociadas a déficit neurológico previo
- Puede ocurrir en menores de 6 meses y mayores de 6 años
- Puede haber historia familiar de epilepsia

### **Asociación entre CF y el desarrollo posterior de una epilepsia**

Depende de los factores de riesgo que cada niño tenga. Los más importantes son los que definen, precisamente, a una Convulsión febril compleja.

Estudios epidemiológicos (Camfield 2002) han demostrado que el 2% de los niños que tienen CF simples y el 4-15% de los que tuvieron CFc pueden desarrollar una epilepsia posterior.

La historia familiar de epilepsia y el número de crisis, más de tres, estarían asociados a las epilepsias generalizadas; mientras que la duración de la crisis, la afectación focal y el status febril (de más de 30 minutos de duración), estarían relacionados con la epilepsia del lóbulo temporal.

### **Factores de riesgo asociados a recurrencia:**

- CF compleja
- Familiar de primer grado con antecedentes de CF
- Convulsión asociada a fiebre baja
- Primer episodio en menor de 12 meses de edad
- Múltiples episodios convulsivos bajo el mismo registro de fiebre.

## **Neuroimagen**

Ante la presunción clínica de una lesión estructural, por la presencia de anomalías neurológicas focales, retardo psicomotor, síndrome neurocutáneo coexistente, o anormal circunferencia craneana, entre otras posibilidades.

## **EEG**

Después de la primera **CF simple no** se justifica ya que no hay evidencia clínica consistente de que un EEG de rutina pueda predecir recurrencia de CF o de epilepsia posterior si la convulsión tiene claras características clínicas de CFs.

**Criterios de internación** (American Academy of Pediatrics 1996).

## **Menores de 18 meses**

Debemos considerar la internación. En pacientes > de 18 meses si luego de la crisis el niño se encuentra clínicamente estable, sin signos ni síntomas que sugieran necesidad de estudios diagnósticos, la internación es innecesaria y sólo se deberán dar a los padres instrucciones y pautas de alarma para el tratamiento del síndrome febril.

## **Convulsión febril compleja**

La internación se recomienda ya sea para su tratamiento si se tratara de una convulsión prolongada o para su mejor estudio.

## **Indicación de PL** ("Guía Practica 2018" – Dr. Montero)

Historia de irritabilidad, letargo o rechazo del alimento

Compromiso del estado general

Status convulsivo

Postictal prolongado

Signos de meningitis

Pretratamiento con ATB orales

Menor de 12 meses con esquema de vacunación incompleto

Se observa meningitis en el 2-5% de las CF, sin embargo la forma de presentación en el 25% de las meningitis es una CF. El 18% de los Status convulsivos se deben a meningitis.

## **Tratamiento profilaxis**

La medicación antitérmica profiláctica no previene el riesgo de secuelas, ni el desarrollo de epilepsia, y **no** disminuye el riesgo de recurrencia.

El paciente con antecedentes de CF debe recibir antitérmicos al alcanzar los 38°C de temperatura axilar.

La ILAE plantea valorar tratamiento preventivo en pacientes que presenten crisis muy frecuentes en un periodo de tiempo (3 o más en 6 meses, 4 o más en 1 año) y en pacientes con historia de crisis prolongadas (duración mayor de 15 minutos) o que requieran tratamiento farmacológico para detener la crisis. En estos casos, consideran la indicación de terapia intermitente con diazepam rectal u oral al inicio de la fiebre con 1 dosis a 0,4-0,5 mg/ kg, pudiendo dar una segunda dosis a las 8 horas.

Dado que el 98% de las crisis febriles ocurren en las primeras 24 horas, no se considera prolongar el tratamiento más allá de este tiempo.

Es frecuente que la crisis febril aparezca antes del ascenso de temperatura, lo que impide que se pueda realizar esta pauta como profilaxis eficaz.

En algunos casos, puede ser necesario que los familiares dispongan de medicación para abortar la crisis, bien por dificultades para acceder a un centro sanitario, por crisis muy frecuentes o bien por antecedentes de crisis prolongadas.

La disponibilidad de cánulas de diazepam rectal en el domicilio es una práctica frecuente y segura en estos pacientes.

## Status convulsivo

Una CF puede evolucionar a *status*, en torno al 5% de los casos.

### Definición

En el 2015, la ILAE reorientó la definición de *status*

*“Actividad comicial continua o recidivante sin recuperación de la conciencia, con un componente motor, durante más de 5 minutos.”*

Anteriormente el punto de corte estaba en 30 minutos pero se han reducido ya que las crisis que se prolongan más allá de unos 5 minutos, constituyen una emergencia pediátrica que requiere tratamiento inmediato y agresivo.

Desde los 30 minutos puede producir la muerte neuronal, la lesión neuronal y la alteración de las redes neuronales. Aunque en el caso de los *status* febriles, el pronóstico es mejor al descrito inicialmente.

### Causas

- 25% son de causa idiopática afebril
- 25% son *status* febriles
- 50% son pacientes epilépticos crónicos

La causa más frecuente es la suspensión brusca de la medicación en un paciente con diagnóstico de epilepsia.

## Exámenes complementarios en status convulsivo

### Laboratorio:

- Hemograma
- Calcemia
- Fosfatemia
- Magnesemia
- Glucemia
- Ionograma
- Dosar anticonvulsivantes en paciente epiléptico
- Dosar tóxicos en sangre y orina según antecedentes
- **Hemoglucotest**
- **Electroencefalograma** evaluado por Neurología
- **Neuroimágenes:** No se recomiendan de rutina, excepto que se observe algún signo de hipertensión endocraneal o signos de foco neurológico.

## Convulsiones afebriles

### Exámenes complementarios iniciales

#### 1. Analítica: para evaluación de causas metabólicas

- Glucemia (o HGT al ingreso)
- < 6m: Ionograma, calcemia, magnesemia

Excepto en los niños menores de seis meses, en quienes la hiponatremia (menos de 125 mM/L) puede estar asociada con crisis epilépticas, las alteraciones metabólicas como la hiper o hipoglucemia o los trastornos electrolíticos, raramente son causa de convulsiones y, si lo son, muestran otros signos o síntomas clínicos que orientan a pedir análisis de laboratorio. ("Convulsiones": EducaSAP).

- Antes del inicio de tratamiento anticonvulsivante:
  - Hemograma
  - Uremia
  - Función hepática con coagulograma

#### 2. EEG

**De vigilia** con las activaciones necesarias (hiperventilación y estimulación luminosa intermitente) y el **EEG de sueño**.

En torno al 40% de los niños epilépticos tienen un EEG interictal basal normal (pero solo un 8% si se realizan activaciones adecuadas, como privación de sueño, hiperventilación y fotoestimulación).

La intensidad de las anomalías epileptógenas no siempre refleja la severidad o importancia del cuadro epiléptico.

#### 3. Video doméstico

Se ha convertido en una importante herramienta para la orientación inicial diagnóstica.

#### 4. Imágenes

##### • TAC

Útil en situaciones agudas para identificar una lesión causante (hemorragias, infartos, tumores bien definidos, o lesiones calcificadas).

La sensibilidad de esta técnica es baja para el estudio de las epilepsias:

**alrededor del 30% para la mayoría de las series.**

La TC podría ser la imagen de elección si la RMN no estuviera disponible.

##### • RMN

De alta sensibilidad, gran resolución anatómica y con mejores imágenes de la fosa temporal que la TC.

La mayoría de epilepsias requieren, para un proceso completo de estudio de su realización, en particular, las epilepsias focales, las no clasificables o las de difícil control.

La incidencia de lesiones que requieran una intervención aguda en niño, es baja de alrededor del 1%.

Puede decirse que no es preciso si existe diagnóstico sindrómico claro no ligado a patología focal (como en la mayoría de las generalizadas idiopáticas, o en síndromes genéticos como el Dravet).

#### 5. ECG si se sospecha síncope secundario a arritmias

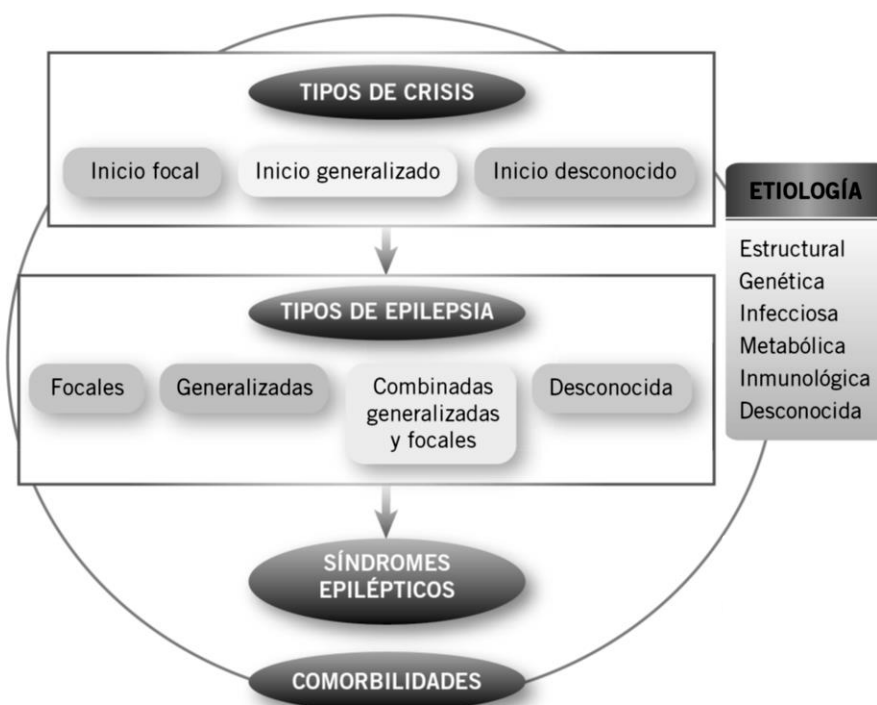
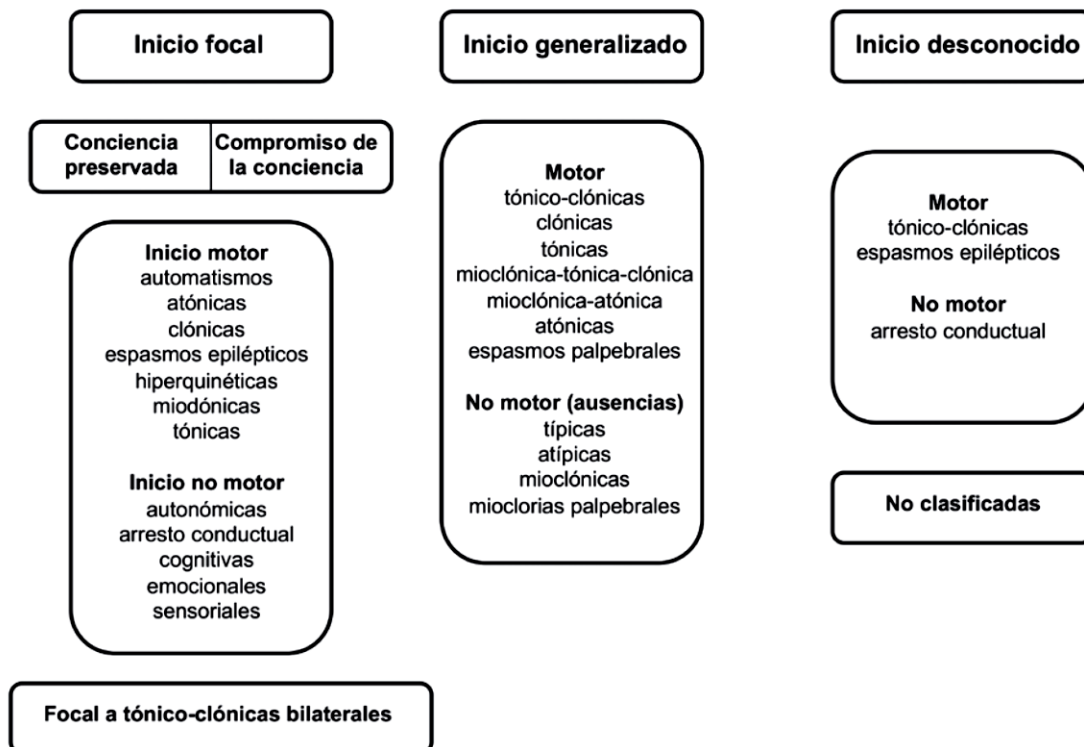
## Epilepsia

- 1) La presencia de al menos dos crisis no provocadas o reflejas (inducidas por un estímulo: lumínico, auditivo, táctil, otros) que ocurran en un plazo superior a 24 horas.
- 2) Diagnóstico o reconocimiento de un síndrome epiléptico bien definido, es decir que algunos casos pueden presentar un sólo episodio convulsivo, pero si el tipo de epilepsia es bien determinado confirma el diagnóstico de epilepsia (Fisher y col., 2014).

## Encefalopatía epiléptica

Cuando la propia actividad epiléptica en sí misma contribuye al deterioro progresivo de la función cerebral (con discapacidad cognitiva, motora, etc.) y en la que la mejoría de la actividad epiléptica podría minimizar esta discapacidad.

## Clasificación de la “Liga Internacional contra la Epilepsia” (ILAE 2017)



## **Epilepsia de inicio focal**

Cuando existen signos y síntomas debidos a la activación inicial de un grupo de neuronas limitado a un hemisferio cerebral, que se denomina foco epileptógeno, con: semiología crítica motora, sensitiva, sensorial, psíquica o autonómica específicamente atribuida a esa zona neuronal.

Pueden ocurrir con conciencia preservada (en terminología previa “parcial simple”), o bien con conciencia alterada (término anterior “parcial compleja”), en las que existe percepción alterada (pero no inconsciencia).

## **Epilepsia de inicio generalizada**

Existe compromiso de ambos hemisferios cerebrales desde el inicio, e incluyen pérdida de conciencia, salvo en las crisis mioclónicas y atónicas, de gran brevedad.

## **Síndromes epilépticos**

Es importante hacer notar que no todas las epilepsias pueden ser encuadradas dentro de un síndrome epiléptico definido; de manera expresa.

Existen diversas confusiones y errores habituales en el enfoque diagnóstico de la epilepsia. Es frecuente la confusión entre tipo de convulsión epiléptica y tipo de epilepsia o directamente síndrome. Ejemplos clásicos son: los espasmos epilépticos, típicos del síndrome de West (o previos a), pero no exclusivos, pudiendo aparecer en otros tipos de epilepsia de infancia temprana; o, por ejemplo, las CE tipo ausencias típicas, que son la

CE habitualmente exclusivas de la epilepsia generalizada de tipo ausencias típicas, pero pueden aparecer en otras epilepsias como la epilepsia mioclónica juvenil.

## **Síndromes epilépticos según edad de debut habitual**

### **1. Periodo neonatal**

La semiología de las crisis neonatales es muy diferente a las de otras edades y son frecuentemente secundarias:

- Alteraciones metabólicas
- Hipoxia isquemia
- Infección de SNC
- Otros: cuadros epilépticos específicos, relacionados con alteraciones genéticas

Una gran parte de CE neonatales muestran una semiología “sutil”, las más habituales involucran movimientos orofaciales, como: chupeteo, movimientos linguales y desviación ocular, siendo también posibles alteraciones autonómicas, apnea o movimientos de tipo pedaleo.

La interpretación del EEG neonatal es particularmente compleja.

## **Principales síndromes epilépticos**

### **A. Neonatales:**

#### **1. Epilepsia familiar neonatal autolimitada/benigna**

Las comúnmente llamadas “crisis del quinto día” constituyen un cuadro heterogéneo, relacionado frecuentemente con mutaciones en *KCNQ2* y *KCNQ3*, de herencia autosómico dominante, por lo que pueden existir antecedentes familiares.

Su pico de inicio es entre el 4º y 6º día de vida, pero pueden debutar en las semanas siguientes.

Las CE suelen ser: focales o multifocales, tónicas o clónicas, afectando a ambos hemisferios y, por lo general, asociadas a apnea, breves y frecuentes, ocurriendo principalmente durante la transición sueño-vigilia.

El EEG interictal suele ser normal.

La norma es la resolución espontánea en los primeros meses de vida, sin secuelas, pero con un riesgo de aproximadamente 10 a 15% de epilepsia futura.



## **2. Síndrome de Ohtahara (encefalopatía infantil precoz)**

Las causas más frecuentes son estructurales (porencefalia, hemimegalencefalia y disgenesia) y mutaciones en genes específicos entre otros: *KCNQ2*, *ARX*, *STXBP1*, *CDKL5*, *SCN2A* y *SCN3A*. Las metabolopatías son causa menos habitual.

Suele iniciarse en las primeras semanas de vida, en forma de CE, de tipo espasmos tónicos en el debut, a menudo en salvas.

El EEG muestra un característico brote-supresión continuo en todos los estadios sueño-vigilia que, con el paso de los meses, evoluciona hacia hipsarritmia.

Los pacientes muestran deterioro neurológico global, falleciendo la mayoría en los primeros años de vida.

Se trata de un cuadro farmacorresistente.

## **3. Encefalopatía mioclónica temprana**

Es un cuadro similar al síndrome de Ohtahara.

Hay una mayor asociación con metabolopatías (en particular, hiperglicinemia no cetósica).

El debut suele ser anterior (en las primeras horas de vida), con CE predominantes en forma de mioclonías de la musculatura distal de extremidades, pero con también crisis: clónicas focales, mioclónicas generalizadas o espasmos tónicos, más tardíos.

El EEG es similar al Ohtahara.

El pronóstico vital y secuelar es similar al Ohtahara, pero debe ponerse énfasis en el despistaje de metabolopatías, ya que existe posibilidad de tratamiento específico en algunas de ellas (déficit de piridoxina, ciclos de urea, etc.).

## **B. Lactantes**

### **1. Síndrome de West**

Debuta habitualmente entre los 3-7 meses de edad.

Este síndrome no es específico de un grupo de etiologías, aunque existen algunas causas más proclives a producirlo.

Existe también el síndrome de West secundarios a daño cerebral por ictus perinatal, infección perinatal de SNC y la mayoría de malformaciones cerebrales.

Existen, además, numerosas mutaciones patogénicas que pueden producir encefalopatía epiléptica, debutando como síndrome de West

Debe hacerse una consideración especial hacia las enfermedades neurocutáneas, en particular, la esclerosis tuberosa (ET), dada su particular asociación con el síndrome de West.

Dada la diversidad etiológica del síndrome de West y que el pronóstico se relaciona con la rapidez y eficacia del tratamiento, la identificación rápida de esclerosis tuberosa es una prioridad en cualquier paciente con síndrome de West de causa no obvia (manchas hipomelanósicas y placas fibrosas).

El inicio de tratamiento en este caso se realiza con vigabatrina.

Presenta asociación de hipsarritmia en el EEG con espasmos infantiles que lleva a un de regresión en el desarrollo con TDI.

Los espasmos consisten en una contracción repentina en flexión, extensión o flexo-extensión de la musculatura proximal y del tronco (sobre todo, de miembros superiores, produciendo separación y elevación de ambos brazos con respecto al tronco), en general, simétricos y sincrónicos, con una duración habitual en torno a un segundo de duración, con clara tendencia a ocurrir agrupados en salvas.

Hay farmacorresistencia en más de la mitad de los pacientes, con evolución hacia otros tipos de epilepsia y encefalopatía epiléptica.

Desde el punto de vista diagnóstico, es importante realizar RMC precoz, en torno al 60-70% de pacientes tienen neuroimagen cerebral alterada.

El tratamiento básico del síndrome de West se basa inicialmente en la diferenciación entre síndrome de West de causa estructural en los que suele existir mayor eficacia

de vigabatrina *versus* resto de causas, en los que aparte de tratamientos específicos, suelen ser más eficaces los corticoides.  
Si existe ineficacia de estos dos tratamientos solos o combinados, deben probarse otros fármacos (zonisamida, valproico...), dieta cetogénica, etc.

### **Epilepsia familiar autolimitada/benigna de la infancia**

El caso típico es el de un lactante previamente sano, entre los 3 y 8 meses de edad, que presenta CE agrupadas (varias en unas horas o días), de semiología variada.

El EEG interictal suele ser normal.

Tienen buena respuesta a fármacos.

El pronóstico es bueno, con cese de CE antes de los dos años de edad, sin secuelas.

Los padres suelen tener antecedentes de haber sufrido convulsiones benignas en su infancia. Existen pacientes con mutaciones en *PRRT2* (también relacionado con: coreoatetosis, convulsiones febriles, migraña hemipléjica y ataxia episódica), así como en *SCN2A* y *SCN8A*; las mutaciones patogénicas de estos dos genes pueden producir un espectro amplio de patología, que va desde cuadros relativamente benignos, a encefalopatías epilépticas muy severas.

Tratamiento:

No lo requieren, pero en la práctica es difícil no tratarlas al comienzo, dado que estos lactantes tienen crisis agrupadas, pero debería reducirse el tiempo de tratamiento farmacológico, aunque, luego de la fase aguda, muchos pacientes siguen un tratamiento crónico.

En guardia se debería evitar un tratamiento intensivo, es decir las crisis agrupadas que pueden ocurrir en un mismo día deben ser controladas con el uso de benzodiacepinas habituales.

Todos los fármacos parecen ser eficaces (ácido valproico, carbamazepina, fenobarbital y difenilhidantoína), sin diferencias aparentes entre ellos. El tratamiento se puede suspender un año después del comienzo.

### **Epilepsia mioclónica de la infancia**

Se trata de una epilepsia generalizada idiopática.

Debut entre 6 meses de vida y los 3-4 años, en un paciente sin déficits neurológicos previos.

Las CE suelen ser mioclónicas axiales (tronco y cabeza), con afectación de extremidades superiores, generalmente sin afectación de conciencia y, a menudo, se desencadenan por estímulos sensoriales.

El EEG interictal es generalmente normal y requieren a menudo de registro ictal o de EEG durante el sueño, visualizándose descargas generalizadas de punta onda/polipunta onda y, a veces, fotosensibilidad.

Tratamiento:

Buena respuesta a valproico o a levetiracetam.

Existe un porcentaje apreciable (10-20%) de pacientes que presentan años después déficit cognitivo leve o trastornos de neuroconducta.

Es también posible la recurrencia de crisis en infancia y adolescencia, con otros tipos de epilepsias generalizadas.

### **Epilepsia de la infancia con crisis focales migratorias**

Se trata de una encefalopatía epiléptica que debuta en el primer semestre de vida.

Suele tener origen genético (*KCNT1*, *TBC1D24*).

Las CE se caracterizan por ser crisis focales múltiples de diversa semiología y localización, en particular motoras y autonómicas, con generalización en la mitad de los pacientes.

Existe cierta complejidad en el EEG, apareciendo en el interictal puntas multifocales, pero en el ictal, se aprecian múltiples focos independientes.

La evolución es hacia una epilepsia farmacorresistente, con retraso global en desarrollo.

### **Síndrome de Dravet**

El síndrome de Dravet (SD) o epilepsia mioclónica severa de la infancia es una encefalopatía epiléptica de inicio temprano, caracterizada por epilepsia refractaria asociada a crisis febriles (CF) atípicas y con una cronología característica. En aproximadamente el 80% de los pacientes, el síndrome es causado por mutaciones patogénicas en el gen *SCN1A*, pero pueden existir otros genes implicados.

Pueden producir trastornos convulsivos, que van desde las CF aisladas a combinaciones de estas con CE afebriles, de tipo: mioclónico, focales, crisis tónico-clónicas (epilepsia con CF *plus*), etc. Las diferentes formas clínicas presentan implicación en el desarrollo, que varía, sobre todo, en función de la severidad del cuadro epiléptico.

El debut se produce en un lactante en el primer año de vida, en relación con sus primeros procesos febriles, en forma de CF atípica (por edad, pero también usualmente por focalidad y duración).

En los primeros meses no existe regresión o detención en desarrollo, pero a partir del año de vida este empieza a ser evidente.

EEG interictal: no suele ser específico y, a menudo, es normal a pesar de la elevada frecuencia de la crisis.

En general, a partir de los 5-7 años de edad, existe una fase de estabilización, sin deterioro, pero con discapacidad intelectual ya establecida y con persistencia de CE, aunque menos frecuentes.

El síndrome de Dravet muestra aproximadamente, un 7% de casos de muerte súbita inesperada.

Es una epilepsia farmacorresistente. Deben usarse combinaciones de: valproato, topiramato, benzodiazepinas, estiripentol (y, posiblemente, Cannabidiol en el futuro inmediato); es muy relevante el papel de la dieta cetogénica en este síndrome, de manera específica.

## **C. Infancia**

### **Las epilepsias pediátricas más frecuentes debutan en este periodo**

#### **1. Epilepsias focales benignas (autolimitadas) de la infancia**

Grupo de epilepsias caracterizadas por ser edad dependientes en debut y curso, con síntomas ictales que sugieren focalidad específica, relacionadas a menudo con el sueño. Son idiopáticas, pueden haber algunas variantes genéticas que favorecen su aparición, pero sin un factor etiológico único.

En todos los casos, la privación de sueño o la transición vigilia-sueño son activadores claros en el EEG y debe indicarse esta maniobra si la sospecha es específica.

#### **Principales:**

##### **a. Epilepsia occipital de la infancia de inicio temprano (síndrome de Panayiotopoulos)**

Debut antes de los 5 años

Crisis nocturnas de una semiología, a menudo, difícil de sospechar, ya que predominan: vómitos y signos vegetativos (palidez, síncope, sialorrea...).

Puede existir impresión de alteración del nivel de conciencia, así como desviación ocular y torsión cefálica, junto a más raros movimientos clónicos focales.

Son crisis largas (+/- 30 minutos: el 50%), pero poco frecuentes (50%: 1 o 2 crisis en toda su vida).

EEG con privación: suelen hallarse las puntas occipitales características.

En general el cuadro remite 2-4 años después del debut.

### **b. Epilepsia occipital de la infancia de inicio tardío (síndrome de Gastaut)**

Debut entre los 7-9 años

Existen síntomas visuales claros, como amaurosis y alteraciones de movilidad ocular. Frecuentemente, se acompaña de cefalea migrañosa, breve y, a menudo, clonias focales hemicorporales que generalizar.

Suele haber muchas crisis y breves.

EEG: similar al Panayiotopoulos.

### **c. Epilepsia benigna de la infancia con puntas centrotemporales (epilepsia “rolándica”)**

Síndrome epiléptico infantil **más frecuente** (uno de cada cinco niños epilépticos tiene este diagnóstico).

Debut amplio: 3 años a preadolescencia, (mayor %: 6-8 años).

La mayoría de crisis ocurren en sueño o en transiciones sueño-vigilia, sobre todo, cuando la noche previa ha existido una reducción de número de horas de sueño.

Semiología característica: espasmo hemifacial clónico, con sialorrea e imposibilidad para hablar, pero preservación de conciencia (al tocarle el paciente mira al observador y da la impresión de querer hablar, pero no puede hacerlo); pueden aparecer clonias de hemicuerpo homolateral y generalización.

A pesar de la supuesta benignidad del cuadro, con mayor persistencia de paroxismos nocturnos en EEG podemos encontrar déficits neuropsicológicos y alteraciones del comportamiento.

EEG: actividad de puntas en región centro-temporal uni o bilateral.

## **2. Síndrome de Landau Kleffner**

Encefalopatía epiléptica relacionada posiblemente con las EFBI, pero en el que el papel de mutaciones en gen *GRIN2A* son determinantes.

Debut entre los 3 a 6 años, con desarrollo/lenguaje normal previo.

Presentación: afasia receptiva y expresiva. Puede existir también problemática conductual comórbida.

Existe un amplio repertorio de crisis, en particular, focales motoras y generalizadas.

EEG: en vigilia es similar a EFBI, pero es característica la actividad paroxística continua en sueño NREM, con *status* eléctrico.

## **3. Síndrome de Lennox-Gastaut**

Encefalopatía epiléptica

Debut: 2 a 6 años.

Siempre existe una situación de patología neurológica o de desarrollo más o menos severa.

Tipos de crisis: tónicas, las atónicas con caída y las ausencias atípicas. Pueden también aparecer crisis generalizadas tónico-clónicas, mioclónicas, etc.

EEG: suele existir punta-onda lenta interictal, con actividad paroxística rápida durante el sueño.

Caracterizado por la refractariedad al tratamiento, considerar la dieta cetogénica.

## **4. Epilepsia de ausencias infantiles**

Epilepsia de tipo generalizado idiopático

Acontece en niños sin patología de desarrollo.

Los antecedentes familiares no son infrecuentes.

Es la **segunda epilepsia más frecuente en la infancia**.

Debut: 6 a 7 años de edad.

Crisis típicas: desconexión completa del medio, de inicio y final brusco, habitualmente entre 5-10 segundos, sin atonía.

La hiperventilación produce crisis en la mayoría de pacientes no tratados.

Es una epilepsia que tarda en ser diagnosticada, ya que puede pasar desapercibida con facilidad o no atribuirse patogenicidad a los episodios.

EEG interictal es normal, pero en un registro de cierta longitud, sobre todo, con hiperventilación, aparecen las características descargas de punta-onda generalizada, sincrónicas y simétricas

Tratamiento: suele preferirse la etosuximida sobre el valproico, con uso más inhabitual de lamotrigina y levetiracetam. Suele haber buena respuesta y, en la mayoría de casos, tras retirada de fármacos a los 2-3 años de tratamiento, no existe recurrencia.

## **5. Epilepsia con ausencias mioclónicas**

Epilepsia tipo generalizada

Debut: 6 a 8 años.

Muestra crisis de ausencia, pero con mioclonías bilaterales y difusas, prolongadas (entre 10 segundos y el minuto), por lo que el paciente va elevando los brazos según acontecen las mioclonías, dando aspecto de crisis tónica que no es tal. Suelen existir también crisis tónico-clónicas.

EEG: hay descargas punta-onda generalizadas.

El control de crisis es complicado, con un porcentaje elevado de regresión cognitiva significativa.

## **6. Epilepsia con crisis mioclono atónicas (síndrome de Doose)**

Epilepsia infrecuente

Debut: 3-4 años.

En general, desde una base de desarrollo normal, muestran crisis febriles de debut tardío, que son seguidas de crisis mioclónicas-atónicas.

En una mayoría de pacientes existe regresión, con deterioro cognitivo.

EEG: poco específico.

Es una epilepsia con tendencia a refractariedad.

## **Epilepsia frontal nocturna autosómica dominante**

Se trata de una epilepsia de base genética, habitualmente de transmisión dominante.

El trastorno es de cierta complejidad; ya que, en muchas ocasiones, a la epilepsia le acompaña distonía episódica y coreoatetosis nocturna en sueño NREM.

Debut: entre los 10 años.

Las crisis epilépticas suelen ser casi exclusivamente: nocturnas, motoras, breves, de escasos segundos, que pueden ser de difícil diagnóstico.

Muy habitualmente, se acompañan de miedo o vivencia desagradable, lo que frecuentemente conduce al diagnóstico diferencial con parasomnias (pesadillas, terrores nocturnos).

Es habitual, comorbilidad cognitiva leve o patología psiquiátrica.

## **D. Adolescencia**

### **“La epilepsia mioclónica juvenil”**

#### **Epilepsia mioclónica juvenil**

Sº epiléptico más común en el adulto (que debuta en este periodo).

Si se consideran tanto infancia como periodo de adulto, se trata de la epilepsia más frecuente.

Edad de debut amplia: 5-6 años, con picos a los 12-18 años.

Hay predominio femenino.

Es una epilepsia generalizada idiopática.

Presenta crisis mioclónicas distales al despertar en extremidades superiores y crisis tónico-clónicas más adelante, junto a ausencias.

EEG: suele mostrar polipunta-onda generalizada y, comúnmente, respuesta fotoparoxística.

Tratamiento: la mejor respuesta se obtiene con valproato, pero dada la recomendación de evitación de dicho fármaco en mujeres, debe recurrirse a menudo a: levetiracetam, benzodiacepinas, etc.

En la mayoría de pacientes debe mantenerse tratamiento de por vida.

### **Epilepsia de ausencias juvenil**

Es una epilepsia generalizada.

Debut: al principio de la adolescencia.

Presentación: al inicio crisis de ausencias, apareciendo con posterioridad, crisis tónico-clónicas.

EEG: aparecen descargas generalizadas de punta-onda.

La respuesta a fármacos es peor que en ausencias típicas y suele requerirse tratamiento mantenido de por vida.